

Komunikacja w rodzinie

Sposób, w jaki rodzina rozmawia o ChAD, jest jednym z najsilniejszych modyfikowalnych czynników nawrotu. Trzy wzorce do unikania, cztery do wzmacniania — konkretnie, do ćwiczenia.

CZAS: 45 min · wspólna rozmowa Praktyka 6-12 miesięcy **ŹRÓDŁO:** Miklowitz (2008, FFT); Hooley (2007)

JAK UŻYWAĆ

Karta jest dla **osoby bliskiej + osoby z ChAD razem**. Trzy wzorce komunikacji, które statystycznie zwiększają ryzyko nawrotu: **krytyka** (osądy charakteru), **wrogość** (odrzućcie, agresja słowna), **nadmierne zaangażowanie emocjonalne** (nadopiekuńczość, poświęcenie z poczuciem winy). Razem nazywane **wysoką emocjonalnością wyrażaną**. Cztery wzorce ochronne: konkretne opisy zachowania, oddzielanie choroby od osoby, granice z troską, autonomia w decyzjach. Praktykuj w spokojnych rozmowach — staną się dostępne w trudnych.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Hooley (2007) w meta-analizach pokazała, że **wysoka emocjonalność wyrażana** w rodzinie podwaja ryzyko nawrotu zaburzeń psychicznych w ciągu roku. W ChAD szczególnie krytyka i wrogość są związane z szybszą zmianą faz i większą liczbą hospitalizacji (Miklowitz 1988, Yan i wsp. 2004). Mechanizm: *napięcie domowe* = *przewlekły stresor*, a stres przewlekły w ChAD ma efekt biologiczny (kortyzol, zaburzenie snu, obciążenie układu nagrody). To **nie** jest „winienie rodziny” — to wskazanie modyfikowalnego czynnika. W badaniu Miklowitza (2003) trening rodzinny zmniejszający emocjonalność wyrażaną dał **35% redukcję nawrotów** w 2 lata.

01 ✗ Trzy wzorce do unikania

1 · KRYTYKA

osądy charakteru

„Zawsze tak robisz.” „Jesteś leniwy/-a.” „Specjalnie nie bierzesz leków.”

Co zamiast: opis konkretnego zachowania — „Zauważam, że ostatnio nie wzięłaś/-eś leków. Co się dzieje?”

2 · WROGOŚĆ

odrzućcie, gniew

„Mam dość.” „Ty jesteś tym problemem.” Krzyk, sarkazm, pogarda. Niewerbalne: wzrok, westchnięcia.

Co zamiast: „Jestem zmęczony/-a. Potrzebuję 15 minut przerwy, wrócę za chwilę.”

3 · NADMIAR TROSKI

poświęcenie + wina

„Rzuciłem/-am wszystko dla ciebie.” „Bez ciebie nie ma sensu.” Kontrolowanie każdej decyzji. Zaniechanie własnego życia.

Co zamiast: autonomia w drobnych decyzjach + obecność w ważnych. „Ufam, że dasz sobie radę. Tu jestem, jeśli będę potrzebny/-a.”

02 ✓ Cztery wzorce do wzmacniania

1 · KONKRETNE OPISY ZACHOWANIA

„Zauważam, że *śpisz krócej* niż zwykle” zamiast „Wpadasz w manię”. Konkretnie zostawia miejsce na rozmowę; etykieta zamyka.

2 · ODDZIELENIE CHOROBY OD OSOBY

„To ChAD wpływa na Twoje myślenie” zamiast „Tak myślisz”. Pacjent *nie jest* swoją chorobą — jest osobą, która zmaga się z chorobą.

3 · GRANICE Z TROSKĄ

„Nie zgadzam się na *ten zakup*, ale rozumiem, że jest dla ciebie ważny. Porozmawiajmy o tym po 24 h.” Granica + obecność, nie odcięcie.

4 · AUTONOMIA W DECYZJACH

Pacjent decyduje o *swoich* wyborach (jeśli nie ma kryzysu). Osoba bliska *wspiera*, nie zarządza. Wyjątki: tylko sytuacje z planu kryzysowego.

03 Trzy ćwiczenia komunikacyjne

A · AKTYWNE SŁUCHANIE (15 MIN, RAZ W TYGODNIU)

Jedna osoba mówi przez 5 minut o trudnym temacie. Druga *tylko słucha*, bez komentarza. Następnie powtarza, co zrozumiała: „Słyszę, że...”. Mówca koryguje. Potem zamiana ról.

B · WYRAŻANIE POZYTYWNYCH EMOCJI (CODZIENNIE)

Raz dziennie powiedz drugiej osobie *konkretną rzecz*, którą zauważyłeś/-aś i doceniłeś/-aś: „Doceniam, że dzisiaj przygotowałeś/-aś kolację”. Konkret, nie ogólnik. Cel: 5:1 — pięć pozytywnych komunikatów na jeden trudny.

C · TYGODNIOWY „CHECK-IN” (30 MIN, SOBOTA RANO)

Stałe spotkanie tygodnia. Trzy pytania: „Co działało w tym tygodniu?” „Co było trudne?” „Czego potrzebujemy w następnym?”. Bez wyrzutów, bez wracania do starych krzywd. Spotkanie kończy się po 30 min.

04 Audyt tygodniowy · 4 tygodnie

Każdej niedzieli wieczorem (lub na cotygodniowym check-in) zaznacz: ile razy złapałeś/-am siebie w któryś z 3 wzorców do unikania.

TYDZIEŃ	KRYTYKA <i>liczba</i>	WROGOŚĆ <i>liczba</i>	NADMIAR TROSKI <i>liczba</i>	CO PRÓBOWALIŚMY ZMIEŃĆ
Tyg. 1				
Tyg. 2				
Tyg. 3				
Tyg. 4				

Klucz: najmniej skuteczna jest nadmierna komunikacja o ChAD — gdy choroba staje się jedynym tematem rozmów. Bauer i wsp. (2009) pokazali, że pary, które potrafią *rozmawiać o ChAD wtedy, gdy trzeba, ale również o innych rzeczach przez 80% czasu*, mają najwyższą satysfakcję związku i najmniej nawrotów. ChAD to ważna część życia, ale **nie całe życie**. Zostawcie sobie miejsce na zwykłość — kolację, film, plany, spacer — bez zaglądania w wykres nastroju.